

NS 22231568156/278

ELISETE DE FATIMA RANGEL

IDADE: 55 anos PESO: 112 ALTURA: 160 PROFISSÃO: Amant social. (Fundador)

SINTOMAS: Dorco, Cansaço Diurno;

QUEIXAS: Dor no mel, Engasgo, perda memória

MEDICAMENTOS: Sertralina, Lorazepam, Anlodipina, Xigdu
Serazek. (muito peg.); Doravon.

MÉDICO: Dra Claudine (Instituto Sono e ortopedista de Maracá).

EXERCÍCIO FÍSICO: Hidroginástica 2x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S

HORA QUE DORME: 23h

HORA QUE ACORDA: 06h

COCHILHO () SIM (X) NÃO

DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO: S

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI: IV

IAH: 48,4 e/h

SPO2: 77%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: S

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

Deno Septo leve (otomano)

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Sim

Avaliou)

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS

menisco

proliferativa

PSG com CPAP = 6,0 cmH₂O (IAH = 6,9 e/h)17/11/2023 Adaptação P fixa: 6,0 cmH₂O Másc Swift (M)24/11 P = 6 cmH₂O

23 IAH = 0,5 e/h

m. de uso: 6h 18'

melhora do engasgo e cansaço.

Relata que teve dificuldade
p/ se ajustar e a
máscara e tubo (Avaliou)04/12/23 P = 6 cmH₂O

IAH = 0,4 e/h

m de uso: 6h 45'

fuga: 3,9 l/min

Bem adaptada; Relata melhora do
cansaço20/12/23 P = 6 cmH₂O

IAH = 0,5 e/h

m de uso: 7h 15'

fuga: 2,5 l/min

Bem adaptada; Sem queixas

17/01/24 P = 6 cmH₂O

IAH = 0,4 e/h

fuga: 6,5 l/min

m de uso: 7 horas

Bem adaptada / Dispositivo

23/02/24 P=6 cm H₂O
IAH=0,5
m. de uso: 6h 33m

Bem adaptada
Volta p/ hidro
Natasha

20/03/24 P=6 cm H₂O
IAH=0,9 e/h
m. de uso: 6h 50'
fuq: 6,4 l/m

Bem adaptada / siqueiros
Natasha

29/05/24 P=6 cm H₂O
IAH=0,4 e/h
m. de uso: 6h 23m
fuq: 4,0 l/m

Bem adaptada
não utilizou alguns dias
devido gripe
Natasha

13/02/25裴 há ± 5 meses apresentou uma crise
valvular e parou de utilizar o CPAP
e agora irá retornar o uso.

Pinical: 4,6 cm H₂O

P=6,0 cm H₂O

* troco filho

Natasha

12/03/25

P=6 cm H₂O
IAH=0,2 e/h
m. de uso: 7h 14min
fuq: 5 l/min

→ vai iniciar novamente
deputa fãl el baulho; queixa ansiedade domin
sugiu lutua / diário sono.

Silvia

22/05/25

nao está usando CPAP m
ficou gripada;

uso: P=6,0 cm H₂O

hoce prony M

→ parou novamente pq ficou Ansiosa e
nervosa
- hiptoma no excitaplan.

↑ ganhou peso / cachorro morreu
↓ rolinha vai carar

06/06/25

P=6,0 cm H₂O
IAH=0,1 e/h
m. de uso: 8 horas
fuq: 2,4 l/min

márcara feuada → hoce márc Pillow (5)

15/07/25

P=6,0 cm H₂O
IAH=0,4 e/h
m. de uso: 6h 30min
fuq: 4,8 l/min

nao usou (somente 4 d / 30 d.)
vai operar Amndre → hñia Abdominal
oienh uso diário. cl coloco tela.

Silvia

Silvia

Nome: ELISETE DE FATIMA RANGEL

Data de Nascimento: 24-1-1968

IMC: 42,97

Sexo: Feminino

Data do exame: 27-05-2023

Peso: 110 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DRA. CLAUDINA DE FREITAS

MORAES OGRIZEK

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 466,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 56,0 e 124,5 minutos. O tempo total de sono foi de 383,0 min, eficiência de 82,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 55,0%; estágio N3: 19,7%; sono REM: 23,2%. O índice de despertares foi de 9,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 6,9/hora, sendo 8 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 36 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 88%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 88 bpm e NREM de 57 - 94 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (22), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (18,8/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: ELISETE DE FATIMA RANGEL

Data de Nascimento: 24-1-1968

IMC: 42,97

Sexo: Feminino

Data do exame: 27-05-2023

Peso: 110 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DRA. CLAUDINA DE FREITAS

MORAES OGRIZEK

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 466,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 56,0 e 124,5 minutos. O tempo total de sono foi de 383,0 min, eficiência de 82,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,1%; estágio N2: 55,0%; estágio N3: 19,7%; sono REM: 23,2%. O índice de despertares foi de 9,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 6,9/hora, sendo 8 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 36 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 88%, permanecendo 0,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 88 bpm e NREM de 57 - 94 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (22), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latências para o sono prolongadas;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (18,8/hora);
7. registro de ronco durante o sono.

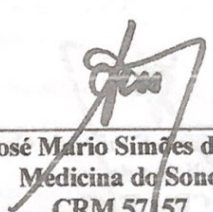
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 6,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157

Nome: ELISETE DE FATIMA RANGEL
Data de Nascimento: 24-1-1968
IMC: 42,97
Sexo: Feminino
Data do exame: 04-03-2023

Peso: 110 kg
Altura: 1,60 m
Médico: DRA. CLAUDINA FREITAS DE
MORAIS OGRIZEK
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 04-03-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 475,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 1,5 e 209,0 minutos. O tempo total de sono foi de 429,0 min, eficiência de 90,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,4%; estágio N2: 63,9%; estágio N3: 16,1%; sono REM: 17,6%. O índice de despertares foi de 34,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 48,4/hora, sendo 40 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 242 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 77%, permanecendo 9,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 101 bpm e NREM de 59 - 96 bpm.

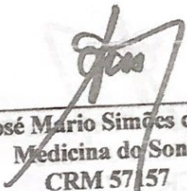
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (17), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 48,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=77%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.
Presença de bruxismo.**

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

CONTR
1. DADOS DA LOCAL
NOME: Faria e M
CNPJ: 13.181
ENDEREÇO:
CEP:
2. DADO
NOME
CPF